



Resifriends
By Fátima Barbosa

RESIFRIENDS · BIBLIOTECA DE ESTUDO · EDIÇÃO APROFUNDADA

Doenças e Agravos

Infectoparasitárias · IST e HIV · Crônicas não transmissíveis · Neoplasias

Dermatológicas · Cuidados paliativos · Nutrição e dietética

PESO MÉDIO · ALTA INCIDÊNCIA

Profa. Fátima Barbosa

Protocolos conferidos · Ministério da Saúde e INCA

O eixo dos protocolos

Aqui a prova cobra número de protocolo: quantas horas para a PEP, quantos meses de RIPE, qual grupo da dengue. São dados objetivos — e por isso mesmo, ponto certo para quem estudou.

Este ebook cobre os sete sub-eixos de doenças e agravos. Os protocolos foram conferidos nas fontes oficiais do Ministério da Saúde e do INCA, porque são justamente os dados que se atualizam.

O MAPA DESTE EIXO

- ◆ **Infectoparasitárias** — dengue, tuberculose, hanseníase.
- ◆ **IST e HIV** — sífilis, PEP, PrEP, prevenção combinada.
- ◆ **Crônicas e neoplasias** — rastreamento, quimioterapia, cuidados.
- ◆ **Dermatológicas, paliativos e nutrição.**

Nota de atualização

Protocolos do Ministério da Saúde são revisados com frequência — o manual da dengue, por exemplo, já vai na 6ª edição. Os dados aqui seguem as versões vigentes. **Confirme a edição do ano antes da prova.**

Sumário

1 Doenças infectoparasitárias

Dengue

Tuberculose

Hanseníase

2 IST e infecção pelo HIV

Sífilis

HIV e prevenção combinada

PEP e PrEP

3 Crônicas não transmissíveis

Conceito e magnitude

Cuidado longitudinal

4 Doenças neoplásicas

Rastreamento

Quimioterapia e cuidados

5 Doenças dermatológicas

Lesões elementares

Cuidados

6 Cuidados paliativos

Princípios

Manejo de sintomas

7 Nutrição e dietética

Vias de nutrição

Cuidados

8 Síntese e bizzos finais

Revisão rápida

1

Doenças infectoparasitárias

Dengue e tuberculose são as campeãs. Protocolo tem número — e número cai.

1 · Dengue

Arbovirose transmitida pelo **Aedes aegypti**. O caso suspeito é definido por febre de **2 a 7 dias** associada a duas ou mais manifestações: náusea, vômitos, exantema, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retro-orbital, petéquias, prova do laço positiva ou leucopenia.

Dengue: diagnóstico e manejo clínico — adulto e criança · Ministério da Saúde

◆ Os sinais de alarme

CAI EM PROVA

- ◆ Dor abdominal intensa e contínua, ou dor à palpação do abdome.
- ◆ Vômitos persistentes.
- ◆ Acúmulo de líquidos (ascite, derrame pleural, pericárdico).
- ◆ Hipotensão postural e/ou lipotimia.
- ◆ Hepatomegalia maior que 2 cm abaixo do rebordo costal.
- ◆ Sangramento de mucosa.
- ◆ Letargia e/ou irritabilidade.
- ◆ Aumento progressivo do hematócrito.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

O detalhe que salva vida — e que a banca adora: os sinais de alarme aparecem **na fase de remissão da febre**, tipicamente entre o 3º e o 7º dia. Ou seja, *quando a febre baixa é que o paciente piora*. A explicação é o extravasamento plasmático que se instala justamente nesse momento. Por isso o paciente e a família precisam ser orientados: **melhorar a febre não é sinal de cura** — é hora de vigiar.

◆ O estadiamento por grupos

GRUPO	DEFINIÇÃO E CONDUTA
Grupo A	Sem sinais de alarme, sem comorbidade, sem risco social. Hidratação oral em domicílio. Acompanhamento ambulatorial.
Grupo B	Sem sinais de alarme, mas com sangramento espontâneo de pele/prova do laço positiva, ou condição especial (lactente, gestante, idoso > 65 anos, comorbidade, risco social). Hidratação oral + hemograma; aguardar resultado na unidade.
Grupo C	Com sinais de alarme , sem gravidade. Hidratação venosa imediata, com internação.
Grupo D	Dengue grave : choque, sangramento grave ou disfunção orgânica. Expansão rápida parenteral e leito de terapia intensiva.

BIZU ESTRATÉGICO

A regra que resolve o estadiamento: **grupos A e B = hidratação ORAL; grupos C e D = hidratação VENOSA**. O que separa B de C é a presença de **sinal de alarme**. O que separa C de D é a **gravidade** (choque/disfunção). Guarde essa escada.

PEGADINHA CLÁSSICA

Trocas frequentes: (1) dar hidratação venosa ao grupo B — não; B é oral. (2) Achar que a queda da febre indica melhora — é o oposto, é o momento de risco. (3) Usar **AAS ou anti-inflamatórios** na dengue: são **contraindicados** pelo risco de sangramento. O antitérmico/analgésico de escolha é o **paracetamol** ou a dipirona.

COMO A BANCA COBRA

“Paciente no 4º dia de doença, febre cedendo, refere dor abdominal intensa e vômitos persistentes. Segundo o manual do Ministério da Saúde, deve ser classificado no grupo... e a conduta é...”

Grupo C, com **hidratação venosa** e internação. O enunciado entrega dois sinais de alarme (dor abdominal intensa + vômitos persistentes) e o momento clássico (remissão da febre).

1 • Tuberculose

Causada pelo *Mycobacterium tuberculosis* (bacilo de Koch), de transmissão por **aerossol**. O **sintomático respiratório** é a pessoa com **tosse por 3 semanas ou mais** — e a busca ativa desse paciente é atribuição central da enfermagem.

Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil • Ministério da Saúde

ITEM	PARÂMETRO
Diagnóstico	Teste rápido molecular (TRM-TB) é o método inicial de escolha; baciloscopia e cultura complementam. Radiografia de tórax auxilia.
Esquema básico	RIPE — Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol.
Duração	6 meses: 2 meses de RIPE (fase intensiva) + 4 meses de RI (fase de manutenção).
TB óssea e meníngea	Esquema prolongado: 12 meses .
Precaução	Aerossol : máscara N95/PFF2 para o profissional, máscara cirúrgica no paciente, quarto com pressão negativa.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que o esquema tem **duas fases**: os dois primeiros meses (RIPE) atacam a população bacilar em multiplicação rápida — é a fase que **corta a transmissão**, e por isso o paciente costuma negativar e melhorar. Os quatro meses seguintes (RI) eliminam os bacilos persistentes, de metabolismo lento. É justamente porque o paciente *se sente curado* na segunda fase que ele abandona — e o abandono gera **resistência**.

BIZU ESTRATÉGICO

Guarde o esquema como **2RIPE/4RI**: dois meses com as quatro drogas, quatro meses com duas. Mnemônico do RIPE: Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida, Etambutol. E a estratégia que garante adesão é o **TDO — Tratamento Diretamente Observado**, em que o profissional observa a tomada.

PEGADINHA CLÁSSICA

Efeitos adversos que caem: a **rifampicina** tinge a urina, o suor e as lágrimas de **laranja-avermelhado** — é esperado e **não** motiva suspensão; orientar o paciente evita abandono. A **isoniazida** causa **neuropatia periférica** (previne-se com piridoxina/vitamina B6). O **etambutol** afeta o *olho* (neurite óptica). A **pirazinamida** eleva o ácido úrico.

1 · Hanseníase

Causada pelo **Mycobacterium leprae**, acomete **pele e nervos periféricos**. A lesão típica é a mancha com **alteração de sensibilidade** — e é isso que a diferencia de qualquer outra dermatose.

CLASSIFICAÇÃO	CARACTERÍSTICA
Paucibacilar (PB)	Até 5 lesões. Poliquimioterapia por 6 meses .
Multibacilar (MB)	Mais de 5 lesões. Poliquimioterapia por 12 meses .
Transmissão	Vias aéreas superiores, contato prolongado com caso MB não tratado.

BIZU ESTRATÉGICO

A chave diagnóstica é a **perda de sensibilidade** na lesão — testa-se térmica, dolorosa e tátil, *nessa ordem* (a térmica é a primeira a se perder). E a regra de ouro: **a partir da primeira dose da poliquimioterapia, o paciente deixa de transmitir**. Não se isola paciente em tratamento.

2

IST e infecção pelo HIV

PEP tem prazo. Sífilis tem esquema. Os dois são cobrados no detalhe.

2 · Sífilis

Causada pelo *Treponema pallidum*. É **doença de notificação compulsória** — sífilis adquirida, em gestante e congênita.

FASE	MANIFESTAÇÃO
Primária	Cancro duro: úlcera única , indolor , de fundo limpo e bordas endurecidas. Cura espontaneamente.
Secundária	Lesões cutâneo-mucosas disseminadas; roséolas e lesões palmo-plantares.
Latente	Assintomática; diagnóstico apenas sorológico.
Terciária	Lesões destrutivas: gomas, comprometimento cardiovascular e neurológico.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que o **cancro duro é indolor** — e por que isso importa: exatamente por não doer, ele passa despercebido, cura sozinho em semanas e o paciente acredita estar curado. Mas a doença *progride*. Essa é a razão de a sífilis ser chamada de “grande simuladora”: ela desaparece dos olhos, não do corpo.

TIPO DE TESTE	FUNÇÃO
Testes treponêmicos	Detectam anticorpos específicos (teste rápido, FTA-Abs). Permanecem reagentes por toda a vida — não servem para controle de cura .
Testes não treponêmicos	VDRL/RPR. São quantitativos (titulação) e servem para monitorar a resposta ao tratamento .

BIZU ESTRATÉGICO

Tratamento: **penicilina benzatina**. Sífilis recente (primária, secundária, latente recente): dose única de 2,4 milhões UI, IM. Sífilis tardia: 2,4 milhões UI por semana, por 3 semanas (total 7,2 milhões UI). Em **gestante**, a penicilina é o **único** tratamento que trata o feto — não há alternativa.

PEGADINHA CLÁSSICA

Duas pegadinhas: (1) usar teste **treponêmico** para controle de cura — não serve, permanece reagente para sempre; o controle é pelo **VDRL** (queda da titulação). (2) Achar que gestante alérgica à penicilina deve receber outro antibiótico — não: procede-se à **dessensibilização**, porque só a penicilina previne a sífilis congênita.

2 · HIV e prevenção combinada

A **prevenção combinada** reúne estratégias biomédicas, comportamentais e estruturais. A enfermagem atua em quase todas elas.

PCDT para PEP de risco à infecção pelo HIV, IST e Hepatites Virais · Ministério da Saúde

ESTRATÉGIA	DEFINIÇÃO
PEP — Profilaxia PÓS-Exposição	Uso de antirretrovirais depois de uma exposição de risco. É urgência .
PrEP — Profilaxia PRÉ-Exposição	Uso antes , contínuo, por pessoas sob risco aumentado.
I = I (Indetectável = Intransmissível)	Pessoa com carga viral indetectável e sustentada não transmite o HIV por via sexual.

◆ PEP — os números que caem

PEP EM CINCO NÚMEROS

- ◆ Iniciar **o mais precocemente possível** — idealmente nas primeiras 2 horas.
- ◆ Limite máximo: **72 horas** após a exposição. Depois disso, **não há benefício**.
- ◆ Duração do esquema: **28 dias**, sem interrupção.
- ◆ Esquema preferencial: **tenofovir/lamivudina (TDF/3TC) + dolutegravir (DTG)**.
- ◆ Disponível no SUS desde **1999**. Indicada em violência sexual, sexo sem preservativo (ou rompimento) e acidente ocupacional.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que **72 horas** é um limite rígido: a PEP funciona bloqueando a replicação viral *antes* que o vírus se estabeleça nos reservatórios do organismo. Passada essa janela, a infecção já se ancorou — e o antirretroviral profilático perde a razão de ser. É por isso que o primeiro atendimento após exposição de risco é tratado como **urgência**: cada hora conta.

BIZU ESTRATÉGICO

Não confunda: **PEP = Pós** (depois, 72h, 28 dias) · **PrEP = Pré** (antes, contínuo). E o atendimento **não deve ser condicionado nem atrasado** pela presença da pessoa-fonte — avalia-se e inicia-se.

PEGADINHA CLÁSSICA

Alternativa dizendo que a PEP “pode ser iniciada em até 7 dias” ou que dura “15 dias” está errada: são **72 horas** de limite e **28 dias** de tratamento. Outra: exposição de **pele íntegra** e mordedura *sem* sangue **não** têm indicação de PEP.

3

Crônicas não transmissíveis

As DCNT lideram a mortalidade no Brasil. O cuidado aqui é longitudinal, não pontual.

3 · As DCNT

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são de **longa duração, múltiplas causas** e curso lento. São a principal causa de morte no país. Os quatro grandes grupos:

GRUPO	CARACTERÍSTICA
Cardiovasculares	Hipertensão, doença coronariana, AVC. Lideram a mortalidade.
Diabetes	Principalmente o tipo 2, ligado ao estilo de vida.
Câncer	Segunda maior causa de morte.
Respiratórias crônicas	DPOC e asma.

◆ Os fatores de risco

TIPO	EXEMPLOS
Modificáveis	Tabagismo, álcool, inatividade física, alimentação inadequada, obesidade. São o alvo da enfermagem.
Não modificáveis	Idade, sexo, hereditariedade, etnia.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que as DCNT compartilham os mesmos quatro fatores de risco modificáveis — tabagismo, álcool, sedentarismo e alimentação inadequada: porque todas passam por vias comuns de **inflamação crônica, disfunção endotelial e resistência insulínica**. É por isso que uma única intervenção (parar de fumar, por exemplo) reduz simultaneamente o risco cardiovascular, oncológico e respiratório. A enfermagem não trata quatro doenças — trata quatro comportamentos.

BIZU ESTRATÉGICO

O cuidado das DCNT é **longitudinal**: acompanhamento contínuo, vínculo, educação em saúde e **auto-cuidado apoiado**. O paciente crônico não é curado — é acompanhado. Enunciado que propõe conduta pontual e isolada para DCNT costuma estar errado.

4

Doenças neoplásicas

Rastreamento salva. Quimioterapia exige cuidado técnico rigoroso.

4 · Rastreamento do câncer

O rastreamento busca detectar a doença em fase pré-clínica, em população assintomática. Os dois rastreamentos organizados no Brasil, e que a enfermagem executa:

Diretrizes de rastreamento · INCA / Ministério da Saúde

CÂNCER	RASTREAMENTO
Câncer do colo do útero	Citopatológico (Papanicolau) em mulheres de 25 a 64 anos que já tiveram atividade sexual. Dois exames anuais consecutivos negativos → repetir a cada 3 anos .
Câncer de mama	Mamografia bienal (a cada 2 anos) em mulheres de 50 a 69 anos , conforme diretriz do Ministério da Saúde.

BIZU ESTRATÉGICO

Decore os números: colo do útero → **25 a 64 anos, 3 em 3 anos** após dois negativos anuais. Mama → **50 a 69 anos, 2 em 2 anos**. Note a lógica: os dois têm faixa etária e intervalo próprios — a banca troca um pelo outro.

PEGADINHA CLÁSSICA

Erro clássico: dizer que o Papanicolau é anual para sempre. Não — após **dois exames anuais consecutivos negativos**, passa a ser **trienal**. Outra: iniciar o rastreio antes dos 25 anos ou em mulher que nunca teve atividade sexual — não está indicado.

4 · Quimioterapia e cuidados

A quimioterapia atinge células de **divisão rápida** — e é isso que explica *todos* os efeitos adversos clássicos.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

A lógica dos efeitos colaterais, deduzida em vez de decorada: a quimio não distingue célula tumoral de célula saudável que se divide rápido. Então ela atinge:

- **Medula óssea** → mielossupressão (neutropenia, anemia, plaquetopenia).
- **Mucosa do trato digestório** → mucosite, náusea, diarreia.
- **Folículo piloso** → alopecia.

Sabendo *onde* ela age, você deduz os efeitos sem lista.

CUIDADOS DE ENFERMAGEM QUE CAEM

- ◆ **Extravasamento**: parar a infusão imediatamente, **não retirar** o cateter, aspirar o resíduo e comunicar. Drogas vesicantes causam necrose.
- ◆ **Neutropenia febril** é **emergência oncológica**: febre em neutropênico exige antibiótico precoce.
- ◆ **Mucosite**: higiene oral cuidadosa, escova macia, evitar antissépticos com álcool.
- ◆ Manipulação de quimioterápicos exige **EPI e câmara de fluxo laminar** — proteção do profissional.

PEGADINHA CLÁSSICA

No **extravasamento**, a banca oferece “retirar imediatamente o cateter” como alternativa. Errado: mantém-se o acesso para **aspirar** o resíduo e, se indicado, administrar antídoto. E febre em paciente neutropênico não é “observar” — é **emergência**.

5

Doenças dermatológicas

Nomear a lesão é metade da questão.

5 · Lesões elementares

A prova cobra o **nome** da lesão a partir da descrição. Guarde as principais:

LESÃO	DEFINIÇÃO
Mácula	Alteração apenas de cor , plana, sem relevo. Ex.: mancha da hanseníase.
Pápula	Elevação sólida, < 1 cm.
Nódulo	Elevação sólida, > 1 cm, mais profunda.
Vesícula	Elevação com líquido claro , < 1 cm. Ex.: varicela, herpes.
Bolha	Como a vesícula, porém > 1 cm.
Pústula	Elevação com pus .
Úlcera	Perda de continuidade que atinge a derme; cicatriza com cicatriz.
Erosão	Perda superficial, restrita à epiderme; cicatriza sem cicatriz.

BIZU ESTRATÉGICO

O critério que organiza quase tudo é **tamanho e conteúdo**: sólida pequena = pápula, sólida grande = nódulo; líquido claro pequeno = vesícula, grande = bolha; com pus = pústula. E plano, só cor = mácula. Guardando o 1 cm como divisor, você resolve a maioria.

6

Cuidados paliativos

Não é desistir do paciente. É mudar o alvo do cuidado.

6 · Princípios

Cuidado paliativo é a abordagem que **melhora a qualidade de vida** de pacientes e famílias diante de doença ameaçadora da vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento — físico, psicossocial e espiritual.

OS PRINCÍPIOS QUE CAEM

- ◆ **Não antecipa nem adia a morte** — não é eutanásia nem obstinação terapêutica.
- ◆ Afirma a vida e considera a morte um **processo natural**.
- ◆ Deve ser iniciado **precocemente**, junto com o tratamento modificador da doença — não só no fim.
- ◆ Oferece suporte à **família**, inclusive no luto.
- ◆ Abordagem **multiprofissional**.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

A distinção que a prova cobra e que confunde muita gente:

- **Eutanásia** — abreviar deliberadamente a vida. *Vedada no Brasil*.
- **Distanásia** — prolongar o morrer com medidas fúteis, às custas de sofrimento (obstinação terapêutica).
- **Ortotanásia** — permitir que a morte siga seu curso natural, sem antecipar nem prolongar; é o que o cuidado paliativo pratica.

Paliativo **não é** “não fazer nada”: é fazer o que alivia, deixando de fazer o que só prolonga o sofrimento.

PEGADINHA CLÁSSICA

Duas trocas campeãs: (1) “cuidado paliativo é indicado apenas quando não há mais nada a fazer / nos últimos dias” — errado: inicia-se **precocemente**, junto ao tratamento curativo. (2) Confundir **ortotanásia** (natural) com **eutanásia** (antecipar). Paliativo pratica a **orto**.

BIZU ESTRATÉGICO

No manejo da dor oncológica, a **escada analgésica da OMS**: degrau 1 → não opioides; degrau 2 → opioides fracos; degrau 3 → opioides fortes (morfina). A dor deve ser tratada em **horários fixos**, não “se necessário”, com doses de resgate para a dor irruptiva. Medo de dependência **não** justifica subtrair a dor.

7

Nutrição e dietética

Nutrir é cuidado — e as vias têm regras.

7 · Vias de nutrição

VIA	INDICAÇÃO
Via oral	Preferencial sempre que possível e segura.
Nutrição enteral	Quando o trato digestório é funcionante mas a via oral é inviável ou insuficiente. Sondas nasogástrica/nasoenteral, gastrostomia, jejunostomia.
Nutrição parenteral	Quando o trato digestório não pode ser usado. Administrada por via venosa, preferencialmente central em soluções hipertônicas.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

A regra de ouro da nutrição — e o racional: “**se o intestino funciona, use-o**”. A nutrição enteral mantém o **trofismo da mucosa** intestinal; sem estímulo alimentar, a mucosa atrofia e a barreira intestinal se fragiliza, favorecendo **translocação bacteriana**. Além disso, a parenteral tem mais complicações infecciosas e metabólicas. Por isso a enteral é preferida sempre que possível.

CUIDADOS NA NUTRIÇÃO ENTERAL

- ◆ **Cabeceira elevada 30–45°** durante e após a infusão — previne broncoaspiração.
- ◆ Confirmar o **posicionamento** da sonda antes de cada administração; radiografia é o padrão-ouro na primeira instalação.
- ◆ **Lavar a sonda** com água antes e depois da dieta e dos medicamentos — previne obstrução.
- ◆ **Não** triturar medicamentos de liberação prolongada nem misturá-los à dieta.
- ◆ Observar resíduo gástrico, distensão, náusea e diarreia.

PEGADINHA CLÁSSICA

Na **parenteral**: a via é **exclusiva** — não se administram medicamentos nem se coleta sangue pelo lúmen da NPT, e a manipulação exige técnica asséptica rigorosa (risco de infecção de corrente sanguínea). A banca oferece “usar o mesmo acesso para antibiótico” — errado.

8

Síntese

Os protocolos que decidem a questão.

8 · Revisão rápida do eixo

INFECTO E IST

- ◆ Dengue: **A e B = oral · C e D = venosa**. Sinais de alarme surgem na **queda da febre**. AAS é contraindicado.
- ◆ TB: **2RIPE/4RI** (6 meses); óssea e meníngea, 12 meses. Sintomático respiratório = tosse ≥ **3 semanas**.
- ◆ Rifampicina tinge urina de laranja (não suspender); isoniazida → neuropatia (B6); etambutol → olho.
- ◆ Hanseníase: PB 6 meses, MB 12 meses. **Primeira dose já corta a transmissão**.
- ◆ Sífilis: penicilina benzatina; controle de cura pelo **VDRL**, nunca pelo treponêmico.
- ◆ PEP: **72 h** de limite, **28 dias** de duração, TDF/3TC + DTG.

NEOPLASIAS, PALIATIVOS E NUTRIÇÃO

- ◆ Colo do útero: **25–64 anos**, trienal após 2 negativos. Mama: **50–69 anos**, bienal.
- ◆ Químio atinge células de divisão rápida → medula, mucosa, folículo piloso.
- ◆ Extravasamento: **não retirar o cateter**; aspirar e comunicar.
- ◆ Paliativo: **ortotanásia**, início **precoce**, escada da OMS, dor em horário fixo.
- ◆ Nutrição: **se o intestino funciona, use-o**. Cabeceira 30–45°. NPT tem via exclusiva.

PEGADINHA CLÁSSICA

As trocas campeãs do eixo: (1) hidratação venosa no grupo B da dengue; (2) suspender rifampicina pela urina laranja; (3) controle de cura da sífilis por teste treponêmico; (4) PEP após 72 h; (5) retirar o cateter no extravasamento; (6) paliativo só no fim da vida. Domine essas seis e o eixo é seu.

“Protocolo não se discute na hora da prova. Se sabe o número, acerta. Se não sabe, chuta.”

Protocolos conferidos nas fontes oficiais: manuais e PCDT do Ministério da Saúde (dengue, tuberculose, hanseníase, PEP/PrEP) e diretrizes de rastreamento do INCA. Protocolos são revisados periodicamente — confirme a edição vigente antes da prova.